

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PERSALINAN SUNGSANG		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.10/I-SPO/MTR/VI/2025	01	1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	penatalaksanaan yang dilakukan terhadap penderita yang akan melahirkan bayi sungsgang yang meliputi persiapan fisik, mental, sarana, dan prasarana dan asisten saat pertolongan persalinan sungsgang.		
Tujuan	1. Persalinan aman dan lancar 2. Mencegah / mengurangi trauma pada ibu dan bayi		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter.		
Prosedur	1) Persiapan a. Persiapan alat 1. Partus set (1 set) 2. Heacting set (1 set) 3. Doek steril (3 buah) 4. Dekatkan alat b. Persiapan Ibu (pasien) 1. Lakukan komunikasi terapeutik kepada ibu 2. Jelaskan tindakan yang akan dilakukan beserta tujuannya 3. Posisikan ibu dalam posisi litotomi pada tempat tidur persalinan 4. Kosongkan kandung kemih, rektum serta membersihkan daerah perineum dengan antiseptik c. Lingkungan aman dan nyaman Pasang sketsel / tutup korden d. Persiapan diri (penolong) Pakai skort, topi, masker, dan alas kaki (sepatu boots) 2) Pelaksanaan 1. Cuci tangan 6 langkah Keringkan dengan handuk/tissu 2. Pakai sarung tangan steril 3. Pasang doek steril diatas perut ibu dan dibawah bokong ibu 4. Lakukan periksa dalam untuk menilai besarnya pembukaan, selaput ketuban dan penurunan bokong serta kemungkinan adanya penyulit 5. Instruksikan pasien agar mengedan dengan benar selama ada his dan anjurkan istirahat diluar his serta berikan pujian kepada ibu 6. Dengarkan denyut jantung janin diluar his		
Prosedur	7. Pimpin berulang kali hingga bokong turun ke dasar panggul. Lakukan episiotomi saat bokong membuka		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PERSALINAN SUNGSANG		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.10/I-SPO/MTR/VI/2025	01	2 / 3
	vulva dan perineum sudah tipis 8. Lahirkan Bayi a. Cara Bracht 1. Segera setelah bokong lahir, bokong dipegang dengan cara kedua ibu jari penolong sejajar dengan sumbu panggul ibu, sedangkan jari-jari lain memegang belakang pinggul bayi 2. Longgarkan tali pusat setelah lahirnya perut dan sebagian dada bayi 3. Lakukan hiperlordosis janin pada saat angulus skapula inferior tampak di bawah simfisis (dengan mengikuti gerak rotasi anterior yaitu punggung janin didekatkan ke arah perut ibu tanpa tarikan) di sesuaikan dengan lahirnya badan bayi 4. Gerakkan ke atas hingga lahir dagu, mulut, hidung, dahi dan kepala 5. Letakkan bayi di atas perut ibu, bungkus bayi dengan handuk hangat, bersihkan jalan nafas bayi, tali pusat dipotong kemudian lakukan asuhan bayi baru lahir b. Cara Lovset (bila terjadi kegagalan dengan Cara Bracht) 1. Setelah bokong dan kaki bayi lahir, pegang pinggul bayi dengan kedua tangan secara femuro pelvic (kedua Ibu jari sejajar spina sacralismidia, jari telunjuk pada krista iliaka dan jari-jari lain mencengkram bagian depan paha) 2. Putar bayi 180° sambil tarik ke bawah dengan lengan bayi yang terjungkit ke arah penunjuk jari tangan yang menjungkit, sehingga lengan posterior berada di bawah simfisis (depan) 3. Bantu melahirkan lengan dengan memasukkan satu jari atau dua jari pada lengan atas serta menarik tangan ke bawah melalui dada sehingga siku dalam keadaan fleksi dan lengan depan lahir 4. Untuk melahirkan lengan kedua, putar kembali 180° kearah yang berlawanan ke kiri atau ke kanan sambil ditarik sehingga lengan belakang menjadi lengan depan dan lahir di depan c. Cara Klasik (bila badan bayi tidak dapat diputar) 1. Pegang pergelangan kaki dan angkat ke atas ke arah perut ibu 2. Lahirkan bahu belakang atau posterior 3. Lahirkan lengan dan tangan belakang 4. Pegang pergelangan kaki dan tarik ke bawah		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN PERSALINAN SUNGSANG		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.10/I-SPO/MTR/VI/2025	01	3 / 3
	5. Lahirkan bahu dan lengan depan d. Cara Mauriceau (melahirkan kepala) 1. Masukkan tangan kiri penolong ke dalam vagina		
Prosedur	2. Letakkan badan bayi di atas tangan kiri sehingga badan bayi seolah-olah menunggang kuda (untuk penolong kidal letakkan badan bayi di atas tangan kanan) 3. Letakkan jari telunjuk dan jari manis kiri pada maksila bayi (fosa canina) dan jari tengah di dalam mulut bayi 4. Tangan kanan memegang atau mencekram tengkuk bahu bayi, dan jari tengah mendorong oksipital sehingga kepala bayi menjadi fleksi 5. Dengan koordinasi tangan kiri dan kanan secara hati-hati tariklah kepala dengan gerakan memutar sesuai dengan jalan lahir 6. Angkat badan bayi (posisi menunggang kuda) ke atas untuk melahirkan mulut, hidung, dan seluruh kepala bayi ➤ Catatan : Minta seorang asisten menekan fundus uteri ibu 3) Dokumentasi 1. Respon pasien pada saat di lakukan tindakan tersebut 2. Nilai kondisi pasien (vital sign, keluhan subyektif, his, BJA, kemajuan persalinan) dan nilai kondisi bayi (apgar skornya)		
Unit Terkait	1. Ruang tindakan persalinan Kandungan & Kebidanan 2. IGD Ponok		